

PARTIE 1

Thrombose veineuse profonde (TVP)

1. Définition

La thrombose veineuse profonde, aussi appelée **phlébite profonde**, correspond à la **formation d'un caillot de sang dans une veine profonde**, le plus souvent au niveau d'un membre inférieur.

Elle entraîne une **obstruction partielle ou totale de la circulation veineuse**.

Le danger principal est que ce caillot puisse **se détacher**, migrer dans la circulation sanguine et provoquer une **embolie pulmonaire**.

2. Causes et facteurs favorisants

La TVP apparaît lorsque les conditions favorisent la coagulation du sang dans une veine.

Causes / facteurs de risque principaux

- **Immobilisation prolongée** : alitement, plâtre, longue période assise, long voyage
- **Intervention chirurgicale** ou traumatisme
- **Perte d'autonomie**, notamment chez la personne âgée
- **Maladies gênant le retour veineux vers le cœur**
 - cancer par compression des veines
 - insuffisance cardiaque
- **Antécédent de phlébite**
- **Contraception hormonale**
- **Grossesse et post-partum**
- **Obésité**
- **Tabagisme**
- **Facteurs héréditaires**

Logique physiopathologique simple

Une thrombose se forme plus facilement quand :

- le sang circule mal ou trop lentement
- la paroi du vaisseau est lésée ou inflammée
- le sang coagule plus facilement que la normale

3. Symptômes

Les symptômes de la phlébite profonde traduisent l'inflammation de la veine et son obstruction par un caillot.

Symptômes principaux

- **Douleur du mollet**, spontanée ou à la palpation
- Douleur pouvant se **propager à toute la jambe**
- **Sensation de lourdeur**
- **Œdème du mollet**
- **Gonflement** du mollet, parfois jusqu'à la cuisse
- **Durcissement** du mollet
- Mollet atteint **plus gros que le mollet sain**
- **Augmentation de la température cutanée**
- Peau **chaude au toucher**
- Parfois **fébricule**

Formule simple à retenir

Mollet douloureux + gonflé + chaud + asymétrique = suspicion de TVP

4. Risques et complications

Complication majeure

La complication la plus grave est l'**embolie pulmonaire**.

Elle survient lorsqu'un fragment du caillot se détache, passe dans la circulation et vient obstruer une artère pulmonaire.

Signes d'alerte d'embolie pulmonaire

- **Gêne respiratoire**
- **Essoufflement**

- **Tachycardie**
- **Douleur brutale dans la poitrine**
- **Malaise**
- **Perte de connaissance**
- **Crachats sanglants**

Autre complication possible

- **Insuffisance veineuse chronique**

PARTIE 2

5. Traitement

Le traitement de la TVP est **médical**. Il ne relève pas de l'ambulancier à l'initiative.

Principes du traitement médical

- **Anticoagulants** pour empêcher l'extension du caillot et réduire le risque d'embolie pulmonaire
- Surveillance médicale
- Parfois contention veineuse selon prescription
- Prise en charge de la cause ou du facteur favorisant

Idée essentielle

Le traitement vise surtout à :

- **éviter l'aggravation de la thrombose**
- **prévenir l'embolie pulmonaire**
- **limiter les séquelles veineuses**

6. Conduite à tenir

Devant une suspicion de TVP

- Faire un **bilan clinique sérieux**
- Rechercher une **douleur**, un **œdème**, une **chaleur locale**, une **asymétrie des mollets**
- Interroger sur les **facteurs de risque** : immobilisation, chirurgie, voyage, grossesse, contraception, antécédents, cancer
- Prendre les **constantes**
- Évaluer la présence de **signes respiratoires ou circulatoires de gravité**

Ce qu'il faut faire

- **Alerter / demander un avis médical** selon l'organisation
- **Surveiller l'état clinique**

- Installer le patient de façon adaptée et le rassurer
- Être particulièrement vigilant au risque d'**embolie pulmonaire**

Ce qu'il faut éviter

- Ne pas banaliser un mollet douloureux et gonflé
- Éviter les efforts inutiles si suspicion importante
- Ne pas confondre avec une simple douleur musculaire sans réflexion clinique

PARTIE 3

Court exposé - Embolie pulmonaire (EP)

1. Définition

L'embolie pulmonaire correspond à l'**obstruction brutale d'une artère pulmonaire ou de l'une de ses branches** par un caillot sanguin.

Dans la majorité des cas, ce caillot provient d'une **thrombose veineuse profonde** du membre inférieur qui s'est détachée puis a migré jusqu'aux poumons.

C'est donc une **complication grave de la TVP**.

2. Causes

Cause principale

- **Migration d'un caillot veineux profond** vers la circulation pulmonaire

Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants sont globalement les mêmes que pour la TVP :

- immobilisation prolongée
- chirurgie récente
- traumatisme
- grossesse et post-partum

- contraception hormonale
- cancer
- obésité
- tabagisme
- antécédents thromboemboliques

3. Symptômes

Les symptômes peuvent être brutaux et d'intensité variable.

Symptômes principaux

- **Essoufflement brutal**
- **Douleur thoracique brutale**
- **Tachycardie**
- **Malaise**
- **Perte de connaissance**
- **Crachats sanglants**
- parfois anxiété importante, sensation d'oppression, agitation

Point important

Une embolie pulmonaire peut survenir après ou en même temps qu'une TVP. Il faut donc penser à l'EP devant une gêne respiratoire brutale chez un patient à risque.

4. Risques

L'embolie pulmonaire est une **urgence potentiellement vitale**.

Principaux risques

- **Détresse respiratoire**
- **Défaillance circulatoire**
- **Arrêt cardiaque**
- aggravation rapide de l'état clinique

5. Traitement

Le traitement est **strictement médical et urgent**.

Principes du traitement médical

- **Oxygénothérapie** si nécessaire
- **Anticoagulants**
- Surveillance rapprochée
- Dans les formes graves : traitement spécialisé hospitalier

Le but est de limiter l'extension du phénomène thromboembolique, de soutenir les fonctions vitales et d'éviter la récurrence.

6. Conduite à tenir

Devant une suspicion d'embolie pulmonaire

- Faire un **bilan immédiat**
- Rechercher une **dyspnée brutale**, une **douleur thoracique**, une **tachycardie**, une **désaturation**, un **malaise**
- Prendre les **constantes**
- Rechercher le contexte : TVP connue ou suspectée, immobilisation, chirurgie, cancer, grossesse, traitement hormonal

Ce qu'il faut faire

- **Alerter sans tarder**
- Installer le patient dans une position adaptée, souvent demi-assise si elle améliore la respiration
- **Administer l'oxygène selon l'état clinique et le protocole applicable**
- Surveiller en continu l'évolution
- Être prêt à prendre en charge une aggravation brutale

Ce qu'il faut retenir

Douleur thoracique brutale + essoufflement + tachycardie chez un patient à risque = penser embolie pulmonaire

7. Résumé express

Définition

Caillot qui bouche une artère pulmonaire.

Cause

Le plus souvent, migration d'une TVP.

Symptômes

Essoufflement brutal, douleur thoracique, tachycardie, malaise.

Risque

Urgence vitale.

Traitement

Oxygène si besoin, anticoagulants, prise en charge médicale urgente.

Conduite à tenir

Bilan rapide, surveillance, oxygène si indiqué, alerte immédiate.